



LAPORAN KEJADIAN

1.	Pembuat Kronologi	Achmad Rizal Tristiyawan, A.Md. Farm
2.	Kejadian	Pelanggaran Prosedur Pengeluaran Sediaan Farmasi
3.	Unit Kerja yang Terlibat	Farmasi
4.	Tanggal Kejadian	4 Juni 2026
5.	Sumber Informasi	Pengakuan Petugas

I. KRONOLOGI KEJADIAN

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang Terlibat
03/06/2026	13:00	Petugas farmasi bernama Achmad Rizal mengambil obat Alprazolam 1mg 1 tablet	Rizal
04/06/2026	15:00	Rizal mengambil lagi 10 tablet	Rizal
	15:10	Rizal menyampaikan kepada Apoteker Lila untuk menginputkan Alprazolam 1 mg 11 tablet dan Apoteker Lila kaget	Rizal Lila
	15:00	- Rizal mengaku apabila 1 tablet yang diambil tanggal 3 Juni 2026 telah dikonsumsi pribadi - Apoteker Aning menyampaikan kepada Rizal agar meminta resep kepada dokter IGD untuk obat yang telah dikonsumsi dan mengembalikan 10 tablet lainnya - Rizal ke IGD dan meminta diresepkan oleh dokter jaga	Rizal Aning Lila
	15:12	- Apoteker Aning menghubungi PLT Kepala Bidang Penunjang Medis dan Umum, Amanda, terkait kasus yang terjadi - Apoteker Aning menjelaskan kronologi kejadian	Aning Amanda
	15:34	- Amanda menyampaikan kepada Direktur, dr. Ifit, terkait kasus yang terjadi - Direktur meminta agar staff unit farmasi menghadap ke kantor	Amanda dr. Ifit
	15:40	- Rizal, Nisa dan Apoteker Aning diminta untuk ke kantor guna menjelaskan kejadian tersebut - Rizal menyatakan penggunaan obat tersebut didasari susah tidur petugas yang sudah terjadi 3 hari ke belakang - Petugas menyangkal adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pengambilan obat di luar prosedur	Rizal Nisa Aning Amanda dr.Ifrit
	16:30	Rizal ke IGD untuk meminta dokter jaga (dr. Dyan) untuk menuliskan resep Alprazolam 1 mg	Rizal dr. Dyan

II. HASIL TELUSUR

- Sdr. Rizal mengambil Alprazolam 1mg total 11 tablet tanpa resep (1 tablet pada 03/06/2026 dan 10 tablet pada 04/06/2026). - Pengambilan dilakukan saat proses penyiapan obat golongan khusus sedang berjalan, di mana kunci lemari dibiarkan menggantung tanpa pengawasan. - Sdr. Rizal mengakui sendiri telah mengonsumsi 1 tablet untuk mengatasi gangguan tidur (insomnia) selama 3 hari terakhir. - Kasus teridentifikasi saat Sdr. Rizal meminta Apoteker Lila menginput data 11 tablet tersebut ke sistem tanpa dokumen pendukung. 10 tablet sisa diamankan, dan Sdr. Rizal diarahkan meminta resep susulan ke dr. Dyan (Dokter Jaga IGD) untuk 1 tablet yang sudah dikonsumsi.



III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Kunci lemari narko-psiko dibiarkan menggantung pada saat aktivitas pelayanan, sehingga fungsi pengamanan ganda tidak berjalan optimal.
 2. Sebagai petugas farmasi yang memiliki hak akses area, Sdr. Rizal memanfaatkan momentum pelayanan untuk mengambil sediaan di luar kebutuhan resep pasien.
 3. Adanya tindakan mengambil barang terlebih dahulu, baru mengupayakan pencatatan sistem dan resep medis di akhir (retrospektif).
 4. Petugas melakukan tindakan jalan pintas medis (self-medication) karena kondisi kesehatan pribadi (insomnia).

IV. KERUGIAN YANG TIMBUL

1. Potensi ketidaksesuaian laporan sediaan psikotropika pada sistem eksternal pelaporan nasional (Kemenkes/BPOM).
 2. Terjadinya celah dalam implementasi standar keselamatan obat (*drug safety*) di lingkungan unit farmasi.
 3. Tersitanya waktu operasional jajaran struktural (Apoteker, Kabid Penunjang, hingga Direktur) untuk penanganan investigasi.
 4. Munculnya kekhawatiran dan kecemasan internal bahwa insiden serupa dapat terulang kembali di masa depan, apabila sistem pengamanan fisik dan pengawasan komitmen staf tidak segera diperbaiki secara fundamental.
 5. Terganggunya rasa saling percaya antar-staf di Unit Farmasi akibat adanya pemanfaatan celah kelalaian operasional (kunci menggantung) untuk kepentingan pribadi.

V. LANGKAH YANG DILAKUKAN

- Eksternal**

 1. Mengarahkan Sdr. Rizal untuk melakukan konsultasi medis formal secara langsung ke IGD agar mendapatkan pemeriksaan dan resep resmi retrospektif dari Dokter Jaga (dr. Dyan) sebagai dasar hukum pemakaian 1 tablet yang telah dikonsumsi.
 2. Melakukan rekonsiliasi data stok fisik dengan pencatatan digital rumah sakit sebelum dilaporkan ke dalam sistem pelaporan nasional eksternal (seperti SIPNAP Kemenkes), guna memastikan kepatuhan regulasi dan mencegah sanksi administratif dari pihak lapor luar.
- Internal**

 1. Menarik kembali 10 tablet Alprazolam 1mg yang belum digunakan untuk disimpan kembali ke dalam lemari penyimpanan resmi.
 2. Memanggil seluruh staf yang terlibat (Rizal, Nisa, dan para Apoteker) ke kantor manajemen untuk dimintai keterangan resmi guna penyusunan Laporan Kejadian.
 3. Mengubah frekuensi pemeriksaan fisik (stock opname) obat golongan khusus menjadi harian (setiap pergantian shift jaga) guna memitigasi risiko repetisi kejadian.
 4. Menyerahkan penanganan staf terkait ke bagian SDM PT untuk penjatuhan sanksi disiplin sesuai regulasi internal, serta merekomendasikan pemeriksaan kesehatan resmi terkait keluhan gangguan tidur yang dialami yang bersangkutan.

VI. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	Tertanda
Kepala Instalasi Farmasi	1. Jika susah tidur sudah 3 hari, lebih baik konsultasi ke dokter terlebih dahulu 2. Tidak menggunakan obat alprazolam secara bebas	 Apt. Dyah Kusumaningrum, S.Farm



Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	Tertanda
PLT Kabid Penunjang Medis dan Umum	1. Evaluasi kinerja 4 bulan ke belakang, karyawan orientasi masih belum beradaptasi dan belum menguasai pekerjaan 2. Tidak dilanjutkan kontrak orientasi.	 Amanda Fharadita Olivia Rakhmad, S.KM
SDM	1. Proses Sesuai Ketentuan	 Saniza Indra Putri Glassya, S.Psi

Menyetujui,
Direktur RS Dharma Husada



(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS.)

Probolinggo, 4 Juni 2026
Pembuat Kronologi,



(Achmad Rizal Tristiyawan, A.Md. Farm)

Catatan Direktur:

1. Kontrak tidak dilanjutkan
2. Diganti TTK baru



Kepada:
Direktur Utama PT Disa Prima Medika

Dengan hormat,
Berikut ini kami kirimkan Laporan Kronologi Pelanggaran Prosedur Pengeluaran Sediaan Farmasi mohon diberikan arahan.

Tanggapan / arahan Direktur PT. Disa Prima Medika:
.....
.....
.....
.....
.....